

PARTE I — O DESPERTAR

Capítulo 1 — O Homem que Morreu Saudável

Ricardo sentiu a primeira pontada quando desligou o carro no estacionamento do escritório. Eram 7h42 da manhã de uma terça-feira. O café ainda estava quente no porta-copos. Ele achou que era azia — talvez o pão de queijo que comeu no trânsito. Abriu a porta, deu dois passos, e a pressão no peito virou um aperto que irradiou para o braço esquerdo e para a mandíbula. As pernas cederam. Ele se apoiou no carro e escorregou até o chão.

Ricardo tinha 52 anos. Era diretor financeiro de uma empresa de tecnologia em São Paulo. Corria três vezes por semana no parque — não era atleta, mas se mantinha ativo. Não fumava há quinze anos. Bebia socialmente. Dormia razoavelmente bem, considerando a rotina de executivo. Era, por qualquer critério informal, um homem saudável.

Oito meses antes daquela terça-feira, Ricardo havia feito seu check-up anual. O resultado foi o que ele esperava: tudo normal. Colesterol total dentro da faixa, glicemia em jejum de 99 mg/dL, pressão arterial 128/82 — “um pouquinho acima, mas nada preocupante”, disse o médico — e eletrocardiograma sem alterações. Recebeu um aperto de mão e a orientação de voltar no ano seguinte.

Ricardo nunca chegou a essa consulta.

No estacionamento, o que aconteceu foi um infarto agudo do miocárdio — uma placa de gordura instável dentro de uma artéria coronária rompeu sem aviso, formando um coágulo que bloqueou o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. Um colega o encontrou, chamou o SAMU. Os paramédicos chegaram em onze minutos. Ricardo sobreviveu. Muitos não sobrevivem.

Quando me procurou no consultório, três meses depois de receber um stent e de ouvir que “deu sorte”, a primeira pergunta que Ricardo me fez foi a mesma que talvez você esteja se fazendo agora:

“Doutor, como é possível? Eu fazia check-up todo ano.”

O Problema Não Era Ricardo. O Problema Era o Check-up.

Eu ouço essa pergunta quase toda semana. E a resposta, por mais desconfortável que seja, é simples: o check-up convencional não foi desenhado para encontrar a doença antes dela se manifestar. Ele foi desenhado para confirmar que você ainda não tem um diagnóstico.

Parece a mesma coisa. Não é.

Existe uma diferença brutal entre “você não tem diabetes” e “seu metabolismo está funcionando de forma ótima”. Entre “seu colesterol está dentro da faixa” e “suas artérias estão limpas”. Entre “seu eletrocardiograma está normal” e “seu coração está seguro pelos próximos vinte anos”.

O check-up que Ricardo fazia — e que provavelmente você faz — opera dentro de um modelo que o médico americano Peter Attia chama de Medicina 2.0. É a medicina reativa: esperar o problema aparecer para então tratá-lo. Você vai ao médico quando tem sintomas. Os exames procuram doenças já instaladas. Se nada é encontrado, você recebe um selo de “saúdável” e vai embora tranquilo.

O problema é que as doenças que mais matam adultos depois dos 40 — doença cardiovascular, doença metabólica, câncer e doenças neurodegenerativas — não começam no dia do diagnóstico. Elas se desenvolvem silenciosamente por 10, 15, às vezes 20 anos antes de qualquer sintoma. O infarto de Ricardo não surgiu naquela terça-feira de manhã. A placa que rompeu já estava se formando havia pelo menos uma década. Ela cresceu em silêncio, alimentada por uma inflamação de baixo grau que nenhum exame de rotina havia investigado.

Aproximadamente metade de todas as mortes por doença coronariana acontecem de forma súbita. E em cerca de metade desses casos, a parada cardíaca é a primeira manifestação da doença. Não houve aviso. Não houve dor no peito progressiva. Não houve “sinal”. Dados do clássico estudo de Framingham mostram que mais de 25% dos infartos passam completamente despercebidos no momento do evento — metade deles sem qualquer sintoma, a outra metade com sintomas vagos que ninguém associou ao coração.

A pergunta que deveríamos estar fazendo não é “tenho alguma doença?”, mas sim: “o que está acontecendo dentro do meu corpo agora que pode se tornar uma doença daqui a dez anos?”

Essa é a pergunta da Medicina 3.0.

A Medicina 3.0: Trocar a Reação pela Antecipação

A Medicina 3.0 é um conceito que ganhou força nos últimos anos, especialmente através do trabalho de Peter Attia — médico que dedicou sua carreira a entender por que morremos e o que podemos fazer, décadas antes, para mudar esse desfecho. Em seu livro *Outlive*, Attia argumenta que a maior revolução na medicina moderna não virá de um novo medicamento ou de uma nova cirurgia. Virá de uma mudança de mentalidade: sair do modelo de esperar a doença para tratá-la e entrar no modelo de identificar o risco e intervir antes.

Pense da seguinte forma. A Medicina 2.0 funciona como um alarme de incêndio: ele só

dispara quando o fogo já começou. Útil? Sim. Mas quando o alarme toca, você já tem chamadas para apagar, danos para consertar, e às vezes o estrago é irreversível.

A Medicina 3.0 funciona como um detector de fumaça calibrado em alta sensibilidade: ele identifica o problema quando ainda é fumaça — quando ainda dá para abrir uma janela, tirar a panela do fogo e evitar que a casa pegue fogo.

Na prática clínica, isso significa três coisas:

Primeiro: ampliar os exames para além do básico. Não basta dosar colesterol total e glicemia em jejum. Precisamos de biomarcadores que mostrem o que está acontecendo antes dos números tradicionais saírem da faixa. Um exemplo concreto: a insulina em jejum — o exame que nenhum check-up de rotina pede — frequentemente começa a subir 5 a 10 anos antes da glicemia se alterar. Quando a glicose finalmente sobe, o pâncreas já está exausto. Se tivéssemos olhado a insulina antes, teríamos visto o problema chegando.

Segundo: usar faixas ótimas, não apenas faixas “normais”. Quando você recebe um resultado de laboratório com a observação “dentro da normalidade”, isso significa que seu número está dentro do intervalo encontrado em 95% da população testada. Mas essa população inclui pessoas sedentárias, pessoas com inflamação crônica, pessoas com doenças não diagnosticadas. “Normal” é a média de uma população que não está otimizada. Não é onde você quer estar — é onde a maioria está.

Um exemplo: a hemoglobina glicada (HbA1c) é considerada “normal” até 5,6%. O diagnóstico de pré-diabetes começa em 5,7%. Mas estudos com centenários — pessoas que vivem mais de 100 anos com saúde — mostram consistentemente valores de HbA1c abaixo de 5,2%. A diferença entre 5,5% (normal) e 5,0% (ótimo) pode parecer insignificante no papel, mas ao longo de décadas, essa diferença se traduz em artérias mais limpas, menos inflamação, menos resistência insulínica e menor risco de demência.

Terceiro: rastrear tendências, não fotos isoladas. Um exame é uma fotografia de um único momento. Mas o que importa para longevidade é o filme — a trajetória dos seus números ao longo dos anos. Uma HbA1c que era 4,9% há cinco anos, subiu para 5,2% há dois anos, e agora está em 5,4% ainda é “normal” em cada momento individual. Mas a curva ascendente conta uma história que nenhum resultado isolado revela: seu metabolismo está perdendo terreno. Se ninguém olhar essa tendência, o diagnóstico de pré-diabetes vai chegar daqui a três ou quatro anos como uma “surpresa” — que na verdade vinha sendo anunciada há quase uma década.

O Caso Ricardo, Revisitado

Quando Ricardo veio ao consultório depois do infarto, pedi um painel ampliado — exames que qualquer médico pode solicitar, mas que o check-up convencional não inclui na rotina.

O que apareceu foi o que ninguém havia procurado:

A **insulina de jejum** dele era 14 $\mu\text{IU/mL}$ — “normal” pelo laboratório (referência até 25), mas o dobro do que consideramos ótimo para longevidade (abaixo de 8). Isso indicava resistência insulínica silenciosa há anos.

O **ApoB** — a medida real de partículas aterogênicas que prevê risco cardiovascular melhor que o LDL — era 118 mg/dL. Dentro da faixa de referência do laboratório, mas muito acima do alvo de segurança para alguém que quer proteger suas artérias (abaixo de 90).

A **proteína C-reativa de alta sensibilidade (hs-CRP)** era 2,4 mg/L — abaixo do limite de “risco alto” (3,0), mas muito acima do que consideramos seguro para longevidade (abaixo de 1,0). Suas artérias estavam em estado inflamatório crônico de baixo grau.

A **homocisteína** era 13,8 $\mu\text{mol/L}$ — “normal” (referência até 15), mas acima do nível que a literatura associa a proteção vascular e cognitiva (abaixo de 10).

E a **angiotomografia** feita durante a internação — que avaliou não apenas a artéria do infarto, mas todas as coronárias — revelou placas calcificadas espalhadas por múltiplos vasos. Calculando o equivalente ao escore de cálcio coronariano, a carga de placa de Ricardo correspondia à de um homem de 68 anos. Ele tinha 52. Suas artérias tinham 68. Se esse exame tivesse sido feito antes do infarto — como um simples escore de cálcio de prevenção, que leva cinco minutos e não precisa de contraste —, o resultado teria mudado completamente a conduta.

Nenhum desses números, isoladamente, teria disparado um alarme no check-up tradicional. Todos estavam “dentro da faixa”. Mas juntos, eles contavam uma história inequívoca: Ricardo estava caminhando para um evento cardiovascular havia pelo menos dez anos. O infarto não foi uma surpresa. Foi um desfecho previsível de um processo que ninguém se deu ao trabalho de investigar.

E Se Fosse Com Você?

Quero que você pense por um momento no seu último check-up.

Seu médico pediu insulina de jejum? ApoB? Proteína C-reativa de alta sensibilidade? Homocisteína? Escore de cálcio coronariano?

Se a resposta for não — e na maioria das vezes é não — então o que você tem em mãos não é um mapa de saúde. É um boletim parcial. Com metade das notas faltando.

Isso não quer dizer que seu médico é incompetente. Quer dizer que o sistema não foi desenhado para fazer o que você precisa. O sistema foi desenhado para diagnosticar doenças. Não para preveni-las.

Ricardo sobreviveu. Hoje, com os biomarcadores monitorados, as tendências rastreadas e um plano que integra alimentação, exercício, sono, saúde emocional e acompanhamento médico de precisão, ele está em uma trajetória completamente diferente. Seus números melhoraram. Sua inflamação caiu. Sua resistência insulínica reverteu. Suas artérias não vão rejuvenescer — mas pararam de envelhecer na velocidade que estavam.

Ele teve uma segunda chance. A maioria não tem.

A boa notícia é que você não precisa de um infarto para começar. Você precisa de informação certa, dos exames certos e de um plano que vá além do check-up. Este livro foi escrito para ser esse plano.

O Essencial em 60 Segundos

- A medicina convencional opera no modelo reativo (Medicina 2.0): espera a doença aparecer para tratá-la. A Medicina 3.0 propõe o oposto — identificar o risco e intervir antes dos sintomas.
- O check-up tradicional foi desenhado para confirmar que você não tem um diagnóstico. Não para avaliar se seu corpo está funcionando de forma ótima.
- Três mudanças práticas fazem a diferença: (1) ampliar os exames para além do básico — incluindo insulina de jejum, ApoB, hs-CRP, homocisteína e escore de cálcio coronariano; (2) usar faixas ótimas, não apenas “normais”; (3) rastrear a tendência dos seus números ao longo dos anos, não apenas o resultado de hoje.
- “Normal” no laboratório significa que seu número está na média da população — que inclui pessoas doentes. Não é onde você quer estar.
- A pergunta certa não é “eu tenho alguma doença?” — é “o que está acontecendo no meu corpo agora que pode se tornar um problema daqui a 10 anos?”

Se o check-up convencional não está desenhado para encontrar o perigo cedo, então o que exatamente está tentando matá-lo? No próximo capítulo, vamos conhecer os quatro assassinos silenciosos — as doenças que dominam a mortalidade após os 40 — e entender por que elas passam décadas sem ser notadas.